ANA MATERYAL

120 Hazır Rapor Şablonu

Röntgen, BT, MR ve USG/Doppler için 120 rapor şablonu. Teknik, Karşılaştırma, Bulgular ve Sonuç alanları hazır; siz yalnızca köşeli parantezleri doldurursunuz. Hedef: uzman hocanızın baştan yazmak zorunda kalmadığı bir rapor.

İçindekiler

Şablonlar nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Röntgen (direkt grafi) — 30 şablon

Bölüm 2 · BT — 35 şablon

Bölüm 3 · MR — 25 şablon

Bölüm 4 · USG ve Doppler — 30 şablon

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Şablonlar nasıl kullanılır

Her şablon 4 adımlı metodun yazıya dökülmüş hâlidir: HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE.

> *Şablon düşünmenin yerine geçmez; düşündüğünüzü eksiksiz ve hocanızın beklediği sırayla yazmanızı sağlar.*

ŞABLON ALANI	METOTTAKİ ADIM	NE YAZARSINIZ
Teknik	HAZIRLA	Tetkik, projeksiyon veya sekanslar, kontrast ve faz, teknik yeterlilik. Yetersizse bunu açıkça yazın.
Karşılaştırma	TANIMLA · Karşılaştır	Önceki tetkikin tarihi ve modalitesi; yoksa «karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır».
Bulgular	TARA + TANIMLA	Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla; doğru terim (dansite / sinyal / ekojenite), lokalizasyon, boyut, sınır. Önemli negatifleri de yazın.
Sonuç	ÖZETLE	Klinik soruya yanıt, en önemli bulgu ilk sırada, gerekiyorsa ayırıcı tanı ve öneri. Acil bulgu varsa kime ve saat kaçta bildirildiği.

Köşeli parantezler

Şablonlardaki [sağ/sol], [.. mm], [tarih], [saat] gibi alanlar hastaya özgüdür. Seçenekler eğik çizgiyle verilmiştir: uygun olanı bırakın, diğerlerini silin. Raporu imzalamadan önce metinde tek bir köşeli parantez kalmamalıdır.

1. **Doğru şablonu seçin** — tetkik ve ana bulguya göre. Normal tetkikte «Normal» şablonuyla başlayın.
2. **Teknik ve Karşılaştırma alanlarını doldurun** — önceki tetkiki gerçekten açtıysanız tarihini yazın.
3. **Bulguları kendi taramanıza göre düzenleyin** — şablonda olmayan bulguyu ekleyin, görmediğiniz bulguyu silin.
4. **Sonucu klinik soruya göre yazın** — 200 Sonuç Cümlesi Bankası'ndan uygun cümleyi kullanabilirsiniz.
5. **Tek Sayfa Rapor Kontrol Listesi'ni uygulayın** — sonra imzalayın veya hocanıza gönderin.

Kopyala-yapıştır tuzağı

Taraf, ölçü ve tarih hataları en çok şablondan kalan metinden doğar. Şablondaki her cümleyi gördüğünüz görüntüyle tek tek doğrulayın; görmediğiniz bir şeyi «şablonda var» diye bırakmayın.

Kurum pratiğiniz önce gelir

Bölümünüzün kullandığı rapor formatı, sınıflama sistemleri ve terimler bu şablonlardan farklıysa her zaman bölümünüzün formatını uygulayın. Şablonları ona göre uyarlayın.

BÖLÜM 1

Röntgen (direkt grafi)

30 şablon: 4 normal, 26 nöbet ve rutinde sık bulgu.

001 PA akciğer grafisi · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Göğüs ağrısı, öksürük veya preoperatif değerlendirmede patoloji saptamadığınız erişkin akciğer grafileri.

Teknik: Ayakta PA akciğer grafisi. İnspirasyon ve penetrasyon yeterli, belirgin rotasyon yok.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Trakea orta hatta. Kalp boyutları normal sınırlarda. Mediasten ve hiler yapılar olağan görünümde. Her iki akciğer parankiminde konsolidasyon, kitle veya nodül saptanmadı. Kostofrenik sinüsler açık. Pnömotoraks izlenmedi. Diyafram kubbeleri düzgün konturlu. İzlenen kemik yapılarda belirgin patoloji yok.

Sonuç: Akciğer grafisinde akut kardiyopulmoner patoloji saptanmadı.

002 Ayakta direkt batın grafisi · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Karın ağrısında obstrüksiyon veya serbest hava sorusuna yanıt olarak patoloji görmediğiniz grafiler.

Teknik: Ayakta direkt batın grafisi; diyafram kubbeleri görüntü alanında.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Diyafram altında serbest hava izlenmedi. Hava-sıvı seviyesi oluşturan dilate barsak ansı saptanmadı. Kolon ve rektumda gaz izlenmektedir. Belirgin opak taş görünümü yok. Psoas gölgeleri seçilebilmektedir. İzlenen kemik yapılar olağandır.

Sonuç: Direkt batın grafisinde obstrüksiyon veya serbest hava lehine bulgu saptanmadı.

003 El bileği grafisi · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Düşme veya burkulma sonrası kırık ve çıkık görmediğiniz el bileği grafileri.

Teknik: [Sağ/Sol] el bileği AP ve lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Distal radius, ulna ve karpal kemiklerde akut kırık hattı izlenmedi. Radyokarpal ve interkarpal eklem aralıkları korunmuş, dizilim normaldir. Yumuşak dokularda belirgin şişlik yok.

Sonuç: [Sağ/Sol] el bileğinde akut kemik patolojisi saptanmadı. Skafoid kırığı klinik olarak şüpheliyse okült kırık grafiyle dışlanamaz; klinik takip ve gerekirse ek inceleme önerilir.

004 Diz grafisi · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Diz travması veya ağrısında kemik patolojisi görmediğiniz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] diz AP ve lateral grafiler.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Kırık veya çıkık izlenmedi. Tibiofemoral ve patellofemoral eklem aralıkları korunmuş. Suprapatellar bölgede belirgin efüzyon lehine bulgu yok. Kemik mineralizasyonu olağan.

Sonuç: [Sağ/Sol] diz grafisinde akut kemik patolojisi saptanmadı.

005 PA akciğer grafisi · Pnömotoraks

Ne zaman kullanılır: Göğüs ağrısı, dispne, travma veya girişim sonrası plevral çizgiyi gördüğünüz olgular. Bildirim gerektirebilir.

Teknik: Ayakta PA akciğer grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] hemitoraksta plevral çizginin dışında akciğer damarlanması izlenmeyen pnömotoraks mevcuttur; apeks düzeyinde plevral çizgi ile göğüs duvarı arası [.. mm]. Mediastende kayma [izlenmedi/karşı tarafa doğru]. Kosta kırığı [izlenmedi/... kostada].

Sonuç: [Sağ/Sol] pnömotoraks. Tansiyon lehine radyolojik bulgu [yok/var]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

006 Akciğer grafisi · Tansiyon pnömotoraks bulguları

Ne zaman kullanılır: Geniş pnömotoraksa mediastinal itilmenin eşlik ettiği olgular. Tansiyon pnömotoraks klinik bir tanıdır; grafi beklenmeden tedavi edilmiş olabilir.

Teknik: [PA/Yatak başı AP] akciğer grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] hemitoraksta geniş pnömotoraks; ipsilateral akciğer hilusa doğru kollabe. Mediasten ve trakea karşı tarafa itilmiş, ipsilateral hemidiyafram basıklaşmış, interkostal aralıklar genişlemiştir.

Sonuç: [Sağ/Sol] geniş pnömotoraks ve tansiyon pnömotoraks lehine radyolojik bulgular. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te telefonla bildirilmiştir.

007 PA akciğer grafisi · Plevral efüzyon

Ne zaman kullanılır: Kostofrenik sinüs küntleşmesi veya menisküs görünümü olan olgular.

Teknik: Ayakta PA [± lateral] akciğer grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol/Bilateral] kostofrenik sinüste küntleşme ve menisküs şeklinde konkav üst sınırlı opasite; [az/orta/fazla] miktarda plevral efüzyon ile uyumludur. Komşu akciğerde altta yatan konsolidasyon ayrımı yapılamamaktadır. Mediasten [olağan/karşı tarafa itilmiş].

Sonuç: [Sağ/Sol/Bilateral] [az/orta/fazla] miktarda plevral efüzyon. Altta yatan parankimal patoloji grafide dışlanamaz; klinik ve gerekirse USG ile korelasyon önerilir.

008 PA akciğer grafisi · Lober konsolidasyon

Ne zaman kullanılır: Ateş, öksürük ve hava bronkogramı içeren opasite görülen olgular.

Teknik: Ayakta PA [± lateral] akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [üst/orta/alt] lobda, hava bronkogramları içeren homojen konsolidasyon alanı. Lob hacmi korunmuştur. [Eşlik eden plevral efüzyon izlenmedi/az miktarda plevral efüzyon].

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] konsolidasyon; klinik ile birlikte değerlendirildiğinde pnömoni ile uyumlu olabilir. Tedavi sonrası radyolojik kontrol klinik karara göre önerilir.

009 PA akciğer grafisi · Atelektazi

Ne zaman kullanılır: Hacim kaybı bulguları eşliğinde opasite gördüğünüz olgular.

Teknik: Ayakta PA [± lateral] akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [lob]da hacim kaybı ile birlikte opasite; fissürde [yer değiştirme], ipsilateral hilusta [yukarı/aşağı] çekilme ve hemidiyaframda yükselme.

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] atelektazisi ile uyumlu bulgular. Santral obstrüktif neden açısından klinik korelasyon ve gerekirse toraks BT önerilir.

010 Akciğer grafisi · Kardiyomegali

Ne zaman kullanılır: PA grafide kalp gölgesi büyük görünen olgular. AP grafide kalp boyutu yanıltıcı olabilir; bunu rapora yazın.

Teknik: [PA/AP] akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Kardiyotorasik oran artmıştır. Pulmoner vasküler yapılar [olağan/belirginleşmiş]. Plevral efüzyon [izlenmedi/...].

Sonuç: Kardiyomegali [PA grafide]. Perikardiyal efüzyon ile ayrım grafide yapılamaz; klinik endikasyon varsa ekokardiyografi ile korelasyon önerilir.

011 Akciğer grafisi · Pulmoner ödem

Ne zaman kullanılır: Dispne, kalp yetmezliği veya sıvı yüklenmesi şüphesi olan olgular.

Teknik: [PA/Yatak başı AP] akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Bilateral perihiler yerleşimli, kanat tarzında opasiteler; interstisyel çizgilenmede artış (Kerley B çizgileri), peribronşiyal kalınlaşma ve üst zon damarlarında belirginleşme. Bilateral [az miktarda] plevral efüzyon. Kalp boyutları [artmış/normal].

Sonuç: Pulmoner ödem lehine bulgular; kardiyojenik ödem ile uyumlu olabilir. Klinik korelasyon önerilir.

012 PA akciğer grafisi · Akciğer kitlesi

Ne zaman kullanılır: Yuvarlak, sınırları değerlendirilebilen opasite gördüğünüz olgular.

Teknik: Ayakta PA ve lateral akciğer grafileri.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [üst/orta/alt] zonda [.. mm] boyutunda, [düzgün/lobüle/spiküle] konturlu, yuvarlak opasite. Kalsifikasyon [izlenmedi]. Hiler veya mediastinal genişleme [yok/var]. Plevral efüzyon [yok/var]. Komşu kostalarda destrüksiyon [izlenmedi].

Sonuç: [Sağ/Sol] akciğer [zon] da [.. mm] kitle lezyonu. İleri değerlendirme için kontrastlı toraks BT önerilir.

013 PA akciğer grafisi · Kaviter lezyon

Ne zaman kullanılır: İçinde hava bulunan duvarlı lezyon gördüğünüz olgular.

Teknik: Ayakta PA [± lateral] akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [üst/orta/alt] zonda duvarı [ince/kalın, düzensiz] kaviter lezyon; içinde hava-sıvı seviyesi [var/yok]. Çevresinde [konsolidasyon/nodüler opasiteler].

Sonuç: [Sağ/Sol] [zon] da kaviter lezyon. Ayırıcı tanıda tüberküloz dahil enfeksiyöz süreçler, akciğer apsesi ve kaviter neoplazi yer alır; klinik, mikrobiyolojik korelasyon ve toraks BT önerilir.

014 Akciğer grafisi · Kosta kırığı

Ne zaman kullanılır: Göğüs travması sonrası kortikal devamsızlık gördüğünüz olgular.

Teknik: PA akciğer grafisi [± kosta grafisi].

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [..]. kosta [anterior/lateral/posterior] arkta [deplase olmayan/deplase] kırık hattı. Pnömotoraks izlenmedi. Hemotoraks lehine plevral sıvı [yok/var]. Ciltaltı amfizem [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] [..]. kosta kırığı; eşlik eden pnömotoraks izlenmedi. Direkt grafinin kosta kırıklarını göstermedeki duyarlılığı sınırlıdır.

015 Yatak başı akciğer grafisi · Endotrakeal tüp yeri

Ne zaman kullanılır: Entübasyon sonrası tüp ucu kontrolü istenen yoğun bakım ve acil hastaları.

Teknik: Yatak başı AP akciğer grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Endotrakeal tüpün ucu karinanın [.. cm] üzerinde, trakea orta hattında izlenmektedir. [Nazogastrik tüp ucu mide projeksiyonunda.] Pnömotoraks izlenmedi. [Yeni gelişen opasite yok.]

Sonuç: Endotrakeal tüp ucu karinanın [.. cm] üzerinde [uygun konumda]. / Tüp ucu [sağ ana bronş] projeksiyonunda; klinik ekibe [saat] 'te bildirilmiştir.

016 Yatak başı akciğer grafisi · Santral venöz kateter

Ne zaman kullanılır: SVK takılması sonrası uç yeri ve pnömotoraks kontrolü.

Teknik: Yatak başı AP akciğer grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [internal juguler/subklavyen] yoldan yerleştirilmiş santral venöz kateterin ucu [superior vena kava/kavoatriyal bileşke] projeksiyonundadır. Pnömotoraks izlenmedi. Mediastende yeni genişleme yok.

Sonuç: SVK ucu [superior vena kava] projeksiyonunda. Girişime bağlı pnömotoraks izlenmedi.

017 Akciğer grafisi · Nazogastrik tüp yeri

Ne zaman kullanılır: Beslenme başlanmadan önce NG tüp ucu kontrolü istenen olgular.

Teknik: Yatak başı AP toraks ve üst batın grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Nazogastrik tüp orta hatta özofagus trasesini izleyerek diyaframı geçmekte, ucu sol üst kadranda mide projeksiyonunda izlenmektedir.

Sonuç: Nazogastrik tüp ucu mide projeksiyonunda. / Tüp ucu [sağ ana bronş/özofagus] projeksiyonunda, uygun konumda değil; kullanılmadan önce klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

018 Ayakta grafi · Pnömoperitoneum

Ne zaman kullanılır: Akut karında diyafram altı serbest hava gördüğünüz olgular. Acil bildirim gerektirir.

Teknik: Ayakta akciğer grafisi / ayakta direkt batın grafisi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Bilateral] diyafram kubbesi altında serbest hava ile uyumlu radyolusen alan izlenmektedir.

Sonuç: Pnömoperitoneum (serbest hava). Yakın zamanda cerrahi veya girişim öyküsü yoksa içi boş organ perforasyonu açısından acil klinik değerlendirme önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

019 Ayakta direkt batın grafisi · İnce barsak obstrüksiyonu

Ne zaman kullanılır: Kusma, distansiyon ve gaz-gaita çıkaramama ile gelen olgular.

Teknik: Ayakta direkt batın grafisi [± yatarak].
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Santral yerleşimli, valvulae conniventes izlenen dilate ince barsak ansları ve farklı seviyelerde hava-sıvı seviyeleri. Kolonda gaz [azalmış/izlenmiyor]. Diyafram altında serbest hava yok.

Sonuç: İnce barsak obstrüksiyonu ile uyumlu bulgular. Seviye, neden ve komplikasyon değerlendirmesi için kontrastlı abdomen BT önerilir.

020 Direkt batın grafisi · Sigmoid volvulus şüphesi

Ne zaman kullanılır: Belirgin distansiyonla gelen, özellikle yaşlı hastalarda dev kolon ansı gördüğünüz olgular.

Teknik: Ayakta [± yatarak] direkt batın grafisi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Pelvisten üst kadrana uzanan, haustrasyonları kaybolmuş, belirgin dilate, ters U şeklinde kolon ansı (kahve çekirdeği görünümü).

Sonuç: Sigmoid volvulus lehine bulgular. Acil klinik değerlendirme önerilir; doğrulama ve komplikasyon değerlendirmesi için BT düşünülebilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

021 Direkt üriner sistem grafisi · Opak taş

Ne zaman kullanılır: Yan ağrısında böbrek veya üreter trasesinde opasite gördüğünüz olgular.

Teknik: Direkt üriner sistem grafisi (DÜSG).

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [böbrek/üreter trasesi/pelvis] projeksiyonunda [.. mm] boyutunda opak dansite.

Sonuç: [Sağ/Sol] [lokalizasyon] projeksiyonunda opak taş ile uyumlu olabilecek dansite. Flebolit ayrımı ve obstrüksiyon değerlendirmesi için USG veya kontrastsız BT ile korelasyon önerilir.

022 El bileği grafisi · Distal radius kırığı

Ne zaman kullanılır: Elin üzerine düşme sonrası distal radiusta kırık hattı gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] el bileği AP ve lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] distal radius metafizinde, eklem yüzüne [uzanan/uzanmayan], [dorsal/volar] açılanma gösteren kırık hattı. Ulna stiloid kırığı [eşlik ediyor/eşlik etmiyor]. Radyal boyda kısalma [var/yok].

Sonuç: [Sağ/Sol] distal radius kırığı ([eklem içi/eklem dışı], [dorsal/volar] açılanmalı).

023 El bileği grafisi · Skafoid kırığı

Ne zaman kullanılır: Enfiye çukuru hassasiyeti olan hastalarda skafoidde kırık hattı gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] el bileği AP, lateral ve skafoid grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Skafoid [bel/proksimal kutup/distal kutup] düzeyinde [ince/deplase] kırık hattı. Skafoid yağ çizgisi [silinmiş/korunmuş].

Sonuç: [Sağ/Sol] skafoid [bel] kırığı. Proksimal kutup kırıklarında avasküler nekroz riski açısından ortopedik takip önerilir.

024 Kalça grafisi · Femur boyun kırığı

Ne zaman kullanılır: Düşme sonrası kalça ağrısı ve yürüyememe ile gelen, özellikle yaşlı hastalar.

Teknik: Pelvis AP ve [sağ/sol] kalça lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] femur boynunda [subkapital/transservikal/bazoservikal] kırık hattı; [deplase/deplase olmayan, impakte]. Kalça eklemi [uyumlu].

Sonuç: [Sağ/Sol] femur boyun kırığı ([deplase/deplase olmayan]). Grafi negatif ve klinik şüphe yüksekse okült kırık açısından MR veya BT önerilir.

025 Omuz grafisi · Glenohumeral çıkık

Ne zaman kullanılır: Omuz travması sonrası humerus başının glenoidle uyumsuz olduğu olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] omuz AP ve [skapular Y/aksiller] grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] humerus başı glenoidin [anterior-inferior/posterior] kesiminde; glenohumeral eklem uyumu bozulmuş. Büyük tüberkül kırığı [yok/var]. [Hill-Sachs/Bankart] lehine kemik değişiklik [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: [Sağ/Sol] [anterior/posterior] glenohumeral çıkık. Redüksiyon sonrası kontrol grafi önerilir.

026 Ayak bileği grafisi · Malleol kırığı

Ne zaman kullanılır: Burkulma sonrası malleollerde kırık hattı gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] ayak bileği AP, mortis ve lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [lateral malleol/distal fibula] düzeyinde, sindesmozun [altında/seviyesinde/üstünde] [oblik/transvers] kırık hattı. Medial malleol kırığı [var/yok]. Mortis aralığı [simetrik/medialde genişlemiş]. Yumuşak doku şişliği.

Sonuç: [Sağ/Sol] [lateral malleol] kırığı; mortis [korunmuş/genişlemiş].

027 Bacak grafisi · Tibia şaft kırığı

Ne zaman kullanılır: Yüksek enerjili travma sonrası tibia şaftında kırık gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] cruris AP ve lateral grafiler (diz ve ayak bileği dahil).

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] tibia [proksimal/orta/distal] üçte birlik şaftında [transvers/oblik/spiral/parçalı] kırık; [.. mm] deplasman ve [anterior/posterior] açılanma. Fibula [sağlam/kırık]. Yumuşak dokuda hava [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] tibia şaft kırığı ([kırık tipi]); fibula [sağlam/kırık]. Yumuşak dokuda hava varsa açık kırık açısından klinik korelasyon önerilir.

028 Diz grafisi · Osteoartrit

Ne zaman kullanılır: Kronik diz ağrısı olan, akut travması olmayan hastalar.

Teknik: [Sağ/Sol] diz [ayakta] AP ve lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] dizde [medial/lateral] tibiofemoral eklem aralığında daralma, marjinal osteofitler ve subkondral skleroz. Akut kırık izlenmedi.

Sonuç: [Sağ/Sol] dizde [medial kompartman belirgin] dejeneratif değişiklikler (osteoartrit). Akut kemik patolojisi saptanmadı.

029 Dirsek grafisi (çocuk) · Suprakondiler humerus kırığı

Ne zaman kullanılır: Düşme sonrası dirsek ağrısı olan çocuklarda yağ yastıkçığı işareti veya kırık hattı gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] dirsek AP ve lateral grafiler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Lateral grafide anterior yağ yastıkçığı yükselmiş, posterior yağ yastıkçığı seçilmektedir. Anterior humeral çizgi kapitellumun [orta üçte birinden geçmiyor]. Suprakondiler bölgede [ince/deplase] kırık hattı [izlenmektedir/net seçilmemektedir].

Sonuç: [Sağ/Sol] suprakondiler humerus kırığı ([deplase/deplase olmayan]). Kırık hattı seçilmese de posterior yağ yastıkçığı işareti okült kırık açısından anlamlıdır; ortopedik değerlendirme önerilir.

030 Grafi · Yutulmuş radyoopak yabancı cisim

Ne zaman kullanılır: Yabancı cisim yutma öyküsüyle gelen, özellikle çocuk hastalar.

Teknik: Boyun, toraks ve batını içeren AP [± lateral] grafi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Özofagus üst/orta/distal kesimi/mide/ince barsak] projeksiyonunda [.. mm] boyutunda radyoopak yabancı cisim. Çift halka / çift kontur görünümü [var/yok]. Serbest hava izlenmedi.

Sonuç: [Lokalizasyon] projeksiyonunda radyoopak yabancı cisim. Özofagusta yerleşim veya düğme pil şüphesi acil kabul edilir; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir. Radyolusen yabancı cisimler grafide görülmeyebilir.

BÖLÜM 2

BT

35 şablon: 4 normal, 31 nöbet ve rutinde sık bulgu.

031 Kontrastsız beyin BT · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Baş ağrısı, senkop veya minör kafa travmasında patoloji görmediğiniz olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT; aksiyel kesitler beyin ve kemik penceresinde değerlendirilmiştir.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: İntrakraniyal kanama, kitle etkisi veya orta hat şifti izlenmedi. Gri-beyaz cevher ayrımı korunmuştur. Ventrikül sistemi ve sulkuslar yaşla uyumlu genişliktedir. Bazal sisternler açıktır. Kalvaryumda kırık izlenmedi. Görüntülenen paranazal sinüsler ve mastoid hücreler havalıdır.

Sonuç: Kontrastsız beyin BT'de akut intrakraniyal patoloji saptanmadı. Erken iskemik inme kontrastsız BT'de görülmeyebilir; klinik şüphe sürüyorsa MR-DAG düşünülebilir.

032 Servikal vertebra BT (travma) · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Travma sonrası servikal kemik yaralanma sorusunda patoloji görmediğiniz olgular.

Teknik: Kontrastsız servikal vertebra BT; sagittal ve koronal reformat görüntüler, kemik ve yumuşak doku penceresi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Servikal vertebralarda dizilim korunmuştur. Akut kırık veya çıkık izlenmedi. Faset eklemler uyumlu. Kraniyoservikal bileşke olağan. Prevertebral yumuşak doku kalınlığı olağandır.

Sonuç: Servikal vertebra BT'de akut travmatik kemik patolojisi saptanmadı. Ligamentöz yaralanma BT ile tamamen dışlanamaz; nörolojik bulgu varsa MR önerilir.

033 Toraks BT · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Rutin veya onkolojik olmayan endikasyonlarda patoloji görmediğiniz toraks BT'ler.

Teknik: [IV kontrastlı/Kontrastsız] toraks BT; mediasten ve akciğer penceresinde değerlendirilmiştir.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Mediastende patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. Kalp boyutları normal, perikardiyal efüzyon yok. Ana vasküler yapılar olağan çapta. Akciğer parankiminde konsolidasyon, kitle veya anlamlı nodül saptanmadı. Plevral efüzyon veya pnömotoraks yok. Görüntülenen üst abdomen ve kemik yapılarda patoloji izlenmedi.

Sonuç: Toraks BT'de anlamlı patoloji saptanmadı.

034 Abdomen-pelvis BT · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Karın ağrısında akut patoloji görmediğiniz kontrastlı abdomen-pelvis BT'ler.

Teknik: IV kontrastlı abdomen-pelvis BT, portal venöz faz. Oral kontrast [verilmiştir/verilmemiştir].

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Karaciğer, dalak, pankreas, adrenal bezler ve böbrekler normal boyut ve dansitededir; fokal lezyon saptanmadı. Safra kesesi doğal; intra ve ekstrahepatik safra yolları dilate değil. Barsak anslarında dilatasyon veya duvar kalınlaşması izlenmedi. Apendiks [doğal görünümde/net seçilemedi, sağ alt kadranda inflamasyon bulgusu yok]. Serbest sıvı ve serbest hava yok. Patolojik boyutta lenf nodu yok. Mesane doğal. Kemik yapılarda litik veya blastik lezyon izlenmedi.

Sonuç: Abdomen-pelvis BT'de akut patoloji saptanmadı.

035 Kontrastsız beyin BT · Epidural hematom

Ne zaman kullanılır: Kafa travması sonrası bikonveks hiperdens koleksiyon gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: Kontrastsız beyin BT; beyin ve kemik penceresi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [temporal/parietal/frontal] bölgede, sütür hatlarını geçmeyen, bikonveks (lentiform) şekilli, en kalın yerinde [.. mm] ölçülen hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon. Komşu kalvaryumda [lineer kırık hattı]. Orta hat şifti [.. mm]. Bazal sisternler [açık/silinmiş].

Sonuç: [Sağ/Sol] [bölge] akut epidural hematom; [.. mm] orta hat şifti. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

036 Kontrastsız beyin BT · Subdural hematom

Ne zaman kullanılır: Hilal şeklinde ekstraaksiyel koleksiyon gördüğünüz olgular, özellikle yaşlı ve antikoagülan kullanan hastalar.

Teknik: Kontrastsız beyin BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] hemisfer konveksitesi boyunca, sütür hatlarını geçen, hilal şeklinde, [hiperdens/izodens/hipodens/miks dansiteli] subdural koleksiyon; en kalın yeri [.. mm]. Sulkuslarda silinme, ipsilateral lateral ventrikülde basılanma ve [.. mm] orta hat şifti.

Sonuç: [Sağ/Sol] [akut/subakut/kronik/kronik zeminde akut] subdural hematom; kitle etkisi [var/yok]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

037 Kontrastsız beyin BT · Subaraknoid kanama

Ne zaman kullanılır: Ani başlayan şiddetli baş ağrısı veya travma sonrası sisternlerde hiperdensite gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Bazal sisternler/Sylvian fissürler/interhemisferik fissür/kortikal sulkuslar] içinde hiperdens subaraknoid kanama. İntraventriküler kanama [yok/var]. Ventriküllerde genişleme [yok/var]. Parankimal hematom [yok/var].

Sonuç: [Yaygın/Fokal] subaraknoid kanama. Hidrosefali [yok/var]. Travma öyküsü yoksa anevrizma açısından BT anjiyografi önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

038 Kontrastsız beyin BT · İntraserebral hemoraji

Ne zaman kullanılır: Akut nörolojik defisitle gelen hastada parankim içi hiperdens hematom gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [bazal ganglion/talamus/lober/serebellar] yerleşimli, [.. x .. mm] boyutunda hiperdens parankimal hematom; çevresinde hipodens ödem. Ventriküle açılım [yok/var]. Orta hat şifti [.. mm].

Sonuç: [Sağ/Sol] [lokalizasyon] akut intraparankimal hematom. Altta yatan neden açısından klinik duruma göre ileri inceleme önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

039 Kontrastsız beyin BT · Erken iskemik inme bulguları

Ne zaman kullanılır: Akut fokal nörolojik defisitle inme protokolünde çekilen BT'ler.

Teknik: Kontrastsız beyin BT; inme penceresi ile ek değerlendirme yapılmıştır.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] [MCA sulama alanında/insular kortekste/lentiform nükleusta] gri-beyaz cevher ayrımında silinme ve hafif hipodansite; komşu sulkuslarda silinme. İntrakraniyal kanama izlenmedi.

Sonuç: [Sağ/Sol] [MCA] sulama alanında erken akut iskemi ile uyumlu bulgular; intrakraniyal kanama yok. İnme protokolü kapsamında klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

040 Kontrastsız beyin BT · Hiperdens MCA işareti

Ne zaman kullanılır: İnme şüphesinde MCA'da karşı tarafa göre belirgin hiperdensite gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] MCA [M1/M2] segmentinde karşı tarafa göre belirgin hiperdensite (hiperdens arter işareti). Eşlik eden erken iskemik değişiklik [yok/var]. Kanama izlenmedi.

Sonuç: [Sağ/Sol] MCA'da hiperdens arter işareti; akut trombüs lehine olabilir. BT anjiyografi ile değerlendirme önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

041 Kontrastsız beyin BT · Hidrosefali

Ne zaman kullanılır: Ventriküllerin sulkuslarla orantısız genişlediği olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Lateral ve üçüncü ventriküllerde [ve dördüncü ventrikülde] sulkuslarla orantısız belirgin genişleme. Periventriküler hipodansite [var/yok]. Obstrüksiyon düzeyi: [düzey/net seçilmiyor].

Sonuç: [Obstrüktif/Komünikan] hidrosefali lehine bulgular. Önceki tetkike göre [artış/değişiklik yok]. Akut gelişmişse klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

042 Beyin BT · Kitle ve vazojenik ödem

Ne zaman kullanılır: Baş ağrısı, nöbet veya fokal defisitte kitle etkisi oluşturan lezyon gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız [± IV kontrastlı] beyin BT.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [lob] da [.. mm] boyutunda [izodens/hiperdens] kitle lezyonu; çevresinde parmak benzeri uzanımlar gösteren vazojenik ödem. Kitle etkisi: sulkal silinme, [ipsilateral ventrikülde basılanma], [.. mm] orta hat şifti.

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] kitle lezyonu ve çevresel vazojenik ödem. Karakterizasyon için kontrastlı beyin MR önerilir. Herniasyon bulgusu [yok/var; klinik ekibe bildirilmiştir].

043 Beyin BT · Kalvaryum kırığı

Ne zaman kullanılır: Kafa travmasında kemik penceresinde kırık hattı gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız beyin BT; kemik penceresi ve 3B reformat.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [frontal/parietal/temporal/oksipital] kemikte [lineer/çökme] kırık hattı; çökme miktarı [.. mm]. Komşu ekstraaksiyel kanama [yok/var]. Pnömosefali [yok/var]. Saçlı deride hematom.

Sonuç: [Sağ/Sol] [kemik] [lineer/çökme] kırığı. Eşlik eden intrakraniyal kanama [izlenmedi/...].

044 BT pulmoner anjiyografi · Pulmoner emboli

Ne zaman kullanılır: PE şüphesiyle çekilen BTPA'da dolum defekti gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: BT pulmoner anjiyografi. Pulmoner arter opasifikasyonu [yeterli/yetersiz].
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol/Bilateral] [ana/lober/segmental/subsegmental] pulmoner arterlerde dolum defektleri. Sağ ventrikül/sol ventrikül oranı [artmış/olağan]; interventriküler septumda [düzleşme/sola bombeleşme] [var/yok]. Periferde kama şeklinde konsolidasyon [yok/var; enfarkt ile uyumlu olabilir].

Sonuç: [Bilateral] akut pulmoner tromboemboli. Sağ ventrikül yüklenmesi lehine bulgular [var/yok]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

045 Toraks BT · İnsidental akciğer nodülü

Ne zaman kullanılır: Başka bir nedenle çekilen BT'de rastlantısal olarak nodül gördüğünüz olgular.

Teknik: [IV kontrastlı/Kontrastsız] toraks BT, ince kesit.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [lob] [segment]de [.. mm] boyutunda [solid/yarı solid/buzlu cam] nodül; [düzgün/lobüle/spiküle] konturlu. Kalsifikasyon [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] da [.. mm] [solid] nodül. Takip gerekliliği ve aralığı, hastanın risk profili ve kurumunuzun benimsediği güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir.

046 Toraks BT · Amfizem

Ne zaman kullanılır: Sigara içicisi veya KOAH hastasında amfizem alanları gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız toraks BT; akciğer penceresi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Bilateral [üst lob ağırlıklı] [sentrilobüler/paraseptal/panlobüler] amfizem alanları. [Büller.] Konsolidasyon veya kitle izlenmedi.

Sonuç: [Sentrilobüler] amfizem. Akut parankimal patoloji izlenmedi.

047 Toraks BT · Buzlu cam dansiteleri

Ne zaman kullanılır: Dispne, ateş veya hipoksemide buzlu cam alanları gördüğünüz olgular.

Teknik: [Kontrastsız/IV kontrastlı] toraks BT; akciğer penceresi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Bilateral [periferik/santral/yaygın], [alt lob ağırlıklı] buzlu cam dansiteleri. İnterlobüler septal kalınlaşma [eşlik ediyor (kaldırım taşı görünümü)/eşlik etmiyor]. Plevral efüzyon [yok/var].

Sonuç: Bilateral buzlu cam dansiteleri. Ayırıcı tanıda viral ve atipik enfeksiyonlar, pulmoner ödem, alveoler hemoraji ve diğer inflamatuvar süreçler yer alır; klinik ve laboratuvar korelasyonu önerilir.

048 Toraks BT · Pnömotoraks

Ne zaman kullanılır: Travma veya girişim sonrası BT'de plevral boşlukta hava gördüğünüz olgular.

Teknik: Toraks BT; akciğer penceresi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] hemitoraksta [anterior/apikal/yaygın] yerleşimli, en kalın yerinde [.. mm] pnömotoraks. Mediastinal şift [yok/var]. Pnömomediastinum [yok/var]. Ciltaltı amfizem [yok/var]. Kosta kırıkları [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] [az/orta/geniş] pnömotoraks. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

049 BT anjiyografi · Aort diseksiyonu

Ne zaman kullanılır: Ani başlayan göğüs veya sırt ağrısında intimal flep gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: Kontrastsız ve arteriyel faz BT anjiyografi.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Asendan aortadan/sol subklavyen arter distalinden] başlayıp [düzey]'e kadar uzanan intimal flep; gerçek ve yalancı lümen izlenmektedir. Diseksiyonun [arkus dallarına/çölyak trunkusa/SMA/renal arterlere] uzanımı: [ayrıntı]. Perikardiyal efüzyon [yok/var]. Mediastinal hematom [yok/var].

Sonuç: [Asendan aortayı tutan (Stanford A)/asendan aortayı tutmayan (Stanford B)] aort diseksiyonu. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

050 Abdomen BT · Abdominal aort anevrizması

Ne zaman kullanılır: Karın veya sırt ağrısında ya da rastlantısal olarak aortada genişleme gördüğünüz olgular.

Teknik: [Kontrastlı BT anjiyografi/portal venöz faz abdomen BT].

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: İnfrarenal abdominal aortada maksimum [.. mm] çapında [füziform/sakküler] anevrizmatik genişleme; duvar kalsifikasyonları ve [mural trombüs]. Renal arterlere uzaklık [.. mm]. Periaortik hematom veya yağ dokusunda kirlenme [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: İnfrarenal abdominal aort anevrizması, maksimum çap [.. mm]. Rüptür lehine bulgu [izlenmedi/izlendi]. Rüptür bulgusu varsa acil bulgu olarak klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

051 Abdomen BT · Akut apandisit

Ne zaman kullanılır: Sağ alt kadran ağrısında inflame apendiks gördüğünüz olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen-pelvis BT, portal venöz faz.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Apendiks [.. mm] çapında, duvarı kalınlaşmış ve kontrastlanması artmış; çevre yağ dokusunda kirlenme. Apendikolit [var/yok]. Periapendiküler sıvı, apse veya serbest hava [yok/var].

Sonuç: Akut apandisit ile uyumlu bulgular. Perforasyon veya apse lehine bulgu [izlenmedi/izlendi]. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

052 Abdomen BT · Akut divertikülit

Ne zaman kullanılır: Sol alt kadran ağrısında divertiküllü segmentte inflamasyon gördüğünüz olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen-pelvis BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sigmoid/İnen] kolonda divertiküller; [.. cm] uzunluğunda segmentte duvar kalınlaşması ve perikolik yağ dokusunda kirlenme. Perikolik serbest hava [yok/var]. Apse [yok/var, .. mm].

Sonuç: [Sigmoid] kolonda akut [komplike olmayan/komplike] divertikülit. Akut dönem sonrası kolon değerlendirmesi klinik karara bırakılır.

053 Abdomen BT · İnce barsak obstrüksiyonu

Ne zaman kullanılır: Grafide obstrüksiyon şüphesi olan veya kusma-distansiyonla gelen olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen-pelvis BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Dilate ince barsak ansları ve distalinde kollabe anslar; geçiş zonu [sağ alt kadran/pelvis/...]. Olası neden: [adezyon/herni/kitle/net seçilmiyor]. Barsak duvarında kontrastlanma azalması, mezenterik ödem ve serbest sıvı [yok/var]. Pnömatozis [yok/var].

Sonuç: [Bölge]'de geçiş zonu gösteren mekanik ince barsak obstrüksiyonu; olası neden [neden]. İskemi lehine bulgu [izlenmedi/izlendi]. İskemi bulgusu varsa acil bulgu olarak klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

054 Abdomen BT · Pnömoperitoneum (perforasyon)

Ne zaman kullanılır: Akut karında BT'de serbest hava gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: IV kontrastlı abdomen-pelvis BT; akciğer penceresinde ek değerlendirme.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Karaciğer önünde/periportal/mezenter içinde] serbest hava. Serbest sıvı [yok/var]. Olası perforasyon yeri: [mide/duodenum/kolon]; [duvar defekti/fokal duvar kalınlaşması/çevresel inflamasyon].

Sonuç: Pnömoperitoneum; [olası lokalizasyon] perforasyonu lehine. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

055 Kontrastsız BT · Üreter taşı

Ne zaman kullanılır: Renal kolik şüphesinde taş protokolü BT'ler.

Teknik: Kontrastsız abdomen-pelvis BT (taş protokolü).
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] üreter [proksimal/orta/distal kesiminde/üreterovezikal bileşkede] [.. mm] taş. Proksimal üreter ve toplayıcı sistemde [hafif/orta/belirgin] dilatasyon; perirenal yağ dokusunda kirlenme. Kontralateral böbrekte [taş yok/.. mm taş].

Sonuç: [Sağ/Sol] [distal] üreterde [.. mm] taş ve [hafif] hidroüreteronefroz.

056 Abdomen BT · Akut pankreatit

Ne zaman kullanılır: Klinik ve laboratuvar olarak pankreatit düşünülen, komplikasyon değerlendirmesi istenen olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen BT, [pankreatik faz ve] portal venöz faz.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Pankreas [diffüz/fokal] ödemli; peripankreatik yağ dokusunda kirlenme ve sıvı. Parankimde kontrastlanmayan alan [yok/var]. Safra kesesinde taş [var/yok]. Splenik ve portal ven [açık/trombüs şüphesi].

Sonuç: Akut [interstisyel ödematöz/nekrotizan] pankreatit bulguları. Komplikasyon: [yok/...].

057 Abdomen BT · Karaciğerde çok sayıda metastaz lehine lezyon

Ne zaman kullanılır: Onkoloji hastasında veya ilk kez karaciğerde çok sayıda lezyon gördüğünüz olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen BT, portal venöz faz.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Karaciğerin her iki lobunda, en büyüğü segment [..]'de [.. mm] boyutunda, periferik kontrastlanan çok sayıda hipodens lezyon.

Sonuç: Karaciğerde metastaz ile uyumlu olabilecek çok sayıda lezyon. Önceki tetkike göre [yeni/artmış/stabil]. Klinik ve gerekirse histopatolojik korelasyon önerilir.

058 Travma BT · Dalak yaralanması

Ne zaman kullanılır: Künt karın travmasında dalakta laserasyon veya hematom gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: IV kontrastlı travma BT, arteriyel ve portal venöz faz.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Dalakta [.. mm] uzunluğunda laserasyon / subkapsüler hematom. Perisplenik ve [pelvik] serbest sıvı (hemoperitoneum ile uyumlu). Aktif kontrast ekstravazasyonu [yok/var].

Sonuç: Dalak yaralanması ([laserasyon/hematom]) ve hemoperitoneum. Aktif kanama lehine bulgu [yok/var]. Derecelendirme kurumunuzun kullandığı sisteme göre yapılır. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

059 Abdomen BT · Basit karaciğer kisti

Ne zaman kullanılır: Rastlantısal, tipik görünümlü kistik karaciğer lezyonları.

Teknik: IV kontrastlı abdomen BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Karaciğer segment [..]'de [.. mm] boyutunda, keskin sınırlı, sıvı dansitesinde, duvarı ince, kontrastlanma göstermeyen lezyon.

Sonuç: Karaciğer segment [..]'de basit kist ile uyumlu lezyon.

060 Abdomen BT · Akut kolesistit

Ne zaman kullanılır: Sağ üst kadran ağrısında BT'de safra kesesinde inflamasyon gördüğünüz olgular.

Teknik: IV kontrastlı abdomen BT.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış; perikolesistik sıvı ve yağ dokusunda kirlenme. Lümende [taş seçilmektedir/taş seçilmemektedir]. Duvarda gaz, kontrastlanma kaybı veya perforasyon [yok/var].

Sonuç: Akut kolesistit lehine bulgular. BT'nin safra taşı duyarlılığı sınırlıdır; USG ile korelasyon önerilir.

061 Vertebra BT · Akut vertebra kırığı

Ne zaman kullanılır: Travma sonrası sırt veya bel ağrısında korpusta kırık gördüğünüz olgular.

Teknik: Kontrastsız [torakolomber] BT; sagittal ve koronal reformat.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [L1] vertebra korpusunda [kompresyon/patlama] kırığı; ön yükseklikte kayıp. Arka duvar [korunmuş/retropulse fragman ile spinal kanalda daralma]. Posterior elemanlar [sağlam/kırık].

Sonuç: [L1] vertebrada akut görünümlü [kompresyon/patlama] kırığı; spinal kanalda [daralma var/yok]. Nörolojik bulgu varsa MR önerilir.

062 Paranazal sinüs BT · Sinüzit

Ne zaman kullanılır: Kronik veya tekrarlayan sinüzit şikayetinde çekilen sinüs BT'ler.

Teknik: Kontrastsız paranazal sinüs BT; koronal reformat.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol/Bilateral] [maksiller/etmoid/frontal/sfenoid] sinüste [mukozal kalınlaşma/hava-sıvı seviyesi/tam dolum]. Osteomeatal kompleks [açık/kapalı]. Kemik destrüksiyonu, orbital veya intrakraniyal uzanım izlenmedi.

Sonuç: [Lokalizasyon] sinüzit ile uyumlu bulgular. Hava-sıvı seviyesi akut sinüzitle uyumlu olabilir; klinik korelasyon önerilir.

063 Abdomen BT · İnsidental adrenal nodül

Ne zaman kullanılır: Başka bir nedenle çekilen BT'de adrenal bezde rastlantısal nodül gördüğünüz olgular.

Teknik: [Kontrastsız/IV kontrastlı] abdomen BT.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] adrenal bezde [.. mm] boyutunda, düzgün sınırlı nodül; [kontrastsız dansitesi .. HU/kontrastlı tetkikte karakterizasyon yapılamamaktadır].

Sonuç: [Sağ/Sol] adrenal nodül. Karakterizasyon ve takip gerekliliği güncel kılavuza göre klinik ekiple birlikte belirlenmelidir; gerekirse adrenal protokol BT veya kimyasal şift MR önerilir.

064 Toraks BT · Pnömoni (konsolidasyon)

Ne zaman kullanılır: Grafide net olmayan veya komplikasyon şüphesi olan pnömonilerde çekilen BT'ler.

Teknik: [Kontrastsız/IV kontrastlı] toraks BT.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [lob]da hava bronkogramları içeren konsolidasyon; çevresinde buzlu cam dansiteleri. Plevral efüzyon [yok/var]. Mediastende [reaktif görünümlü] lenf nodları. Kavitasyon veya apse [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] konsolidasyon; enfeksiyöz süreç (pnömoni) ile uyumlu olabilir. Tedavi sonrası kontrol klinik karara göre önerilir.

065 Travma BT · Hemoperitoneum

Ne zaman kullanılır: Künt karın travmasında serbest sıvı gördüğünüz olgular.

Teknik: IV kontrastlı travma BT.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Morison poşu/perisplenik alan/pelvis]te serbest sıvı; dansitesi [.. HU], hemoperitoneum ile uyumlu. Solid organlarda yaralanma [izlenmedi/...]. Barsak duvarı ve mezenterde [patoloji izlenmedi/...].

Sonuç: [Az/Orta/Fazla] miktarda hemoperitoneum. Solid organ yaralanması izlenmemesi durumunda barsak veya mezenter yaralanması açısından klinik takip önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

BÖLÜM 3

MR

25 şablon: 3 normal, 22 rutinde ve nöbette sık bulgu.

066 Beyin MR · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Baş ağrısı, baş dönmesi veya nöbet araştırmasında patoloji görmediğiniz beyin MR'ları.

Teknik: Beyin MR; aksiyel T1, T2, FLAIR, DAG/ADC, [SWI/T2*], [kontrast sonrası T1] sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Beyin parankiminde sinyal anomalisi saptanmadı. DAG'da difüzyon kısıtlanması yok. Ventrikül sistemi ve sulkuslar yaşla uyumlu. Orta hat yapıları olağan. [Kontrast sonrası patolojik kontrastlanma izlenmedi.] Ana arterlerde akım boşlukları izlenmektedir.

Sonuç: Beyin MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.

067 Lomber MR · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Bel ağrısında disk, kök veya kanal patolojisi görmediğiniz olgular.

Teknik: Lomber MR; sagittal T1, T2, STIR ve aksiyel T2 sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Lomber lordoz korunmuş, vertebra dizilimi normal. Vertebra korpus yükseklikleri ve kemik iliği sinyali olağan. İntervertebral disklerde belirgin dejenerasyon veya herniasyon izlenmedi. Spinal kanal ve nöral foramenler açık. Konus medullaris normal düzeyde ve sinyalde.

Sonuç: Lomber MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.

068 Diz MR · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Diz ağrısı veya travmasında yapısal patoloji görmediğiniz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] diz MR; PD yağ baskılı, T1 ve T2 sekanslar, üç düzlem.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Menisküslerde yırtık lehine sinyal artışı izlenmedi. Ön ve arka çapraz bağlar, kollateral bağlar ve ekstansör mekanizma doğal. Kemik iliği ödemi yok. Eklem kıkırdağı korunmuş. Belirgin eklem efüzyonu yok.

Sonuç: [Sağ/Sol] diz MR'da anlamlı patoloji saptanmadı.

069 Beyin MR · Akut enfarkt (DAG)

Ne zaman kullanılır: Akut fokal defisitte difüzyon kısıtlanması gördüğünüz olgular. Bildirim.

Teknik: Beyin MR; DAG/ADC, FLAIR, T2, SWI/T2* sekanslar.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [bölge] de DAG'da hiperintens, ADC haritasında hipointens, difüzyon kısıtlanması gösteren alan. FLAIR'de [belirgin sinyal değişikliği yok/hafif hiperintensite]. Hemorajik transformasyon [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: [Sağ/Sol] [arter] sulama alanında akut enfarkt. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

070 Beyin MR · Demiyelinizan plaklar

Ne zaman kullanılır: Optik nörit, duyu kusuru veya MS takibinde beyaz cevher lezyonları gördüğünüz olgular.

Teknik: Beyin MR; FLAIR (3B tercih edilir), T2, T1, DAG, kontrast sonrası T1.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Periventriküler, [jukstakortikal], [infratentoryal] yerleşimli, korpus kallozuma dik yönlenen ovoid T2/FLAIR hiperintens lezyonlar. Kontrast sonrası [.. lezyonda kontrastlanma/kontrastlanma yok].

Sonuç: Demiyelinizan hastalık ile uyumlu olabilecek beyaz cevher lezyonları. Önceki tetkike göre yeni veya kontrastlanan lezyon [yok/var]. Tanı klinik bulgular ve güncel tanı kriterleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

071 Beyin MR · Halkasal kontrastlanan intraaksiyel kitle

Ne zaman kullanılır: Kitle etkisi ve ödem gösteren, kontrastlanan parankimal lezyonlar.

Teknik: Kontrastlı beyin MR; DAG, [perfüzyon], SWI sekanslar.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [lob] da [.. mm] boyutunda, düzensiz halkasal kontrastlanan, santral nekroz içeren kitle; çevresinde vazojenik ödem ve kitle etkisi. Korpus kallozuma uzanım [yok/var]. Santral kesimde belirgin difüzyon kısıtlanması [yok/var].

Sonuç: [Sağ/Sol] [lob] halkasal kontrastlanan intraaksiyel kitle; ayırıcı tanıda yüksek dereceli glial tümör ve metastaz öncelikli düşünülür. Santralde belirgin difüzyon kısıtlanması varsa apse ayırıcı tanıda yer almalıdır.

072 Beyin MR · Menenjiyom

Ne zaman kullanılır: Dural tabanlı, homojen kontrastlanan ekstraaksiyel kitleler.

Teknik: Kontrastlı beyin MR.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Bölge] de dural tabanlı, [.. mm] boyutunda, T1'de izointens, homojen kontrastlanan ekstraaksiyel kitle; dural kuyruk işareti. Komşu parankimde ödem [yok/var]. Kitle etkisi [yok/var].

Sonuç: [Bölge] de menenjiyom ile uyumlu ekstraaksiyel kitle.

073 Hipofiz MR · Hipofiz adenomu

Ne zaman kullanılır: Hormonal bozukluk veya görme alanı kaybı nedeniyle çekilen hipofiz MR'ları.

Teknik: Hipofiz MR; ince kesit koronal ve sagittal T1, T2, dinamik kontrastlı seriler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Hipofiz bezinde [.. mm] boyutunda, dinamik serilerde normal bezden geç kontrastlanan lezyon. Suprasellar uzanım [yok/var]; optik kiazmaya bası [yok/var]. Kavernöz sinüs invazyonu [şüpheli/yok]. Hipofiz sapı [orta hatta/deviye].

Sonuç: Hipofiz [mikro/makro] adenomu ile uyumlu lezyon. Endokrinolojik korelasyon önerilir.

074 Beyin MR · Beyin apsesi

Ne zaman kullanılır: Ateş ve fokal defisitte düzgün duvarlı halkasal kontrastlanan lezyon gördüğünüz olgular. Bildirim.

Teknik: Kontrastlı beyin MR; DAG/ADC dahil.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Lokalizasyon] da [.. mm] boyutunda, ince ve düzgün duvarlı halkasal kontrastlanan lezyon; içeriği DAG'da belirgin difüzyon kısıtlanması göstermektedir. Çevresel vazojenik ödem.

Sonuç: Beyin apsesi ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

075 Beyin MR ve MR venografi · Venöz sinüs trombozu

Ne zaman kullanılır: Baş ağrısı, nöbet veya papilödem ile gelen, özellikle risk faktörü olan hastalar. Bildirim.

Teknik: Beyin MR ve kontrastlı/kontrastsız MR venografi.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Superior sagittal/transvers/sigmoid] sinüste normal akım boşluğu kaybı ve trombüs ile uyumlu sinyal; MR venografide dolum defekti/akım kaybı. Komşu parankimde venöz enfarkt veya hemoraji [yok/var].

Sonuç: [Sinüs] trombozu. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

076 Beyin MR · Kronik küçük damar hastalığı

Ne zaman kullanılır: Yaşlı veya vasküler risk faktörü olan hastalarda nonspesifik beyaz cevher lezyonları.

Teknik: Beyin MR; FLAIR, T2, DAG sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Bilateral periventriküler ve derin beyaz cevherde punktat ve yer yer birleşme eğiliminde T2/FLAIR hiperintensiteler. DAG'da difüzyon kısıtlanması yok. [Kronik laküner enfarktlar.]

Sonuç: Kronik küçük damar hastalığı ile uyumlu olabilecek beyaz cevher değişiklikleri. Akut enfarkt saptanmadı.

077 Lomber MR · Disk hernisi

Ne zaman kullanılır: Bel ve bacak ağrısı (radikülopati) ile çekilen lomber MR'lar.

Teknik: Lomber MR; sagittal T1, T2 ve aksiyel T2 sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: L [4-5] diskte T2 sinyal kaybı ve yükseklik azalması; [sağ/sol] [paramedian/foraminal] [protrüzyon/ekstrüzyon] tarzında herniasyon. [Sağ/Sol] [L5] sinir kökünde [temas/bası]. Spinal kanal [açık/daralmış]. Nöral foramenler [açık/daralmış].

Sonuç: L [4-5] [sağ paramedian] disk [ekstrüzyonu]; [L5] sinir köküne [bası].

078 Servikal MR · Disk-osteofit kompleksi

Ne zaman kullanılır: Boyun ve kol ağrısı veya uyuşukluk ile çekilen servikal MR'lar.

Teknik: Servikal MR; sagittal T1, T2, STIR ve aksiyel T2 sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: C [5-6] düzeyinde [sağ/sol] [paramedian/foraminal] disk-osteofit kompleksi; [sağ/sol] nöral foramende daralma. Spinal kord sinyali [olağan/T2 hiperintens].

Sonuç: C [5-6] disk-osteofit kompleksi ve [sağ] foraminal daralma. Kordda sinyal değişikliği [yok/var; miyelopati ile uyumlu olabilir].

079 Torakal MR · Epidural bası ve kord basısı

Ne zaman kullanılır: Bilinen malignitesi olan hastada sırt ağrısı veya yeni nörolojik defisit. Acil bildirim.

Teknik: Kontrastlı torakal [ve tüm spinal] MR.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: T [..] vertebrada T1 hipointens, kontrastlanan kemik iliği lezyonu; epidural uzanımla spinal kanalda daralma ve spinal kordda bası. Kordda T2 sinyal artışı [yok/var]. Diğer seviyelerde [ek lezyon yok/ek lezyonlar].

Sonuç: T [..] düzeyinde epidural tümör yayılımı ile uyumlu olabilecek lezyon ve spinal kord basısı. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

080 Lomber MR · Akut kompresyon kırığı

Ne zaman kullanılır: Minör travma veya travmasız bel ağrısında korpus yükseklik kaybı gördüğünüz olgular.

Teknik: Lomber MR; sagittal T1, T2, STIR sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [L1] korpusunda yükseklik kaybı; STIR'de kemik iliği ödemi. Arka duvarda retropulsiyon [yok/var]. Posterior eleman tutulumu, epidural veya paravertebral yumuşak doku kitlesi [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: [L1] vertebrada [akut/subakut] kompresyon kırığı. Patolojik kırık lehine bulgu [izlenmedi/izlendi; ileri değerlendirme önerilir].

081 Diz MR · Ön çapraz bağ yırtığı

Ne zaman kullanılır: Pivot travma sonrası instabilite ve efüzyon ile gelen olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] diz MR; PD yağ baskılı ve T1 sekanslar, üç düzlem.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: ÖÇB'de [proksimal/orta kesim] devamlılık kaybı ve normal lineer görünümün kaybı. Lateral femoral kondil ve posterolateral tibia platosunda kemik kontüzyonu [var/yok]. Eklem efüzyonu.

Sonuç: [Tam kat/Kısmi] ÖÇB yırtığı. Eşlik eden [menisküs/kollateral bağ] patolojisi [yok/var].

082 Diz MR · Menisküs yırtığı

Ne zaman kullanılır: Kilitlenme, eklem hattı ağrısı veya travma sonrası çekilen diz MR'ları.

Teknik: [Sağ/Sol] diz MR; PD yağ baskılı sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Medial/Lateral] menisküs [arka boynuz/gövde/ön boynuz] kesiminde eklem yüzeyine uzanan [horizontal/oblik/radyal/longitudinal] sinyal artışı.
[Yer değiştirmiş menisküs parçası (kova sapı) izlenmedi/izlendi.]

Sonuç: [Medial] menisküs [arka boynuz] [oblik] yırtığı.

083 Diz MR · Kemik kontüzyonu

Ne zaman kullanılır: Travma sonrası grafisi normal olan, MR'da kemik iliği ödemi gördüğünüz olgular.

Teknik: [Sağ/Sol] diz MR; PD yağ baskılı ve T1 sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Lateral femoral kondil/tibia platosu]nda, belirgin kırık hattı izlenmeksizin yağ baskılı serilerde kemik iliği ödemi. T1'de lineer hipointens kırık hattı [yok/var].

Sonuç: [Bölge]de kemik kontüzyonu; [kırık hattı izlenmedi/subkondral kırık hattı izlendi].

084 Omuz MR · Rotator manşet yırtığı

Ne zaman kullanılır: Omuz ağrısı ve abdüksiyon güçsüzlüğü ile çekilen omuz MR'ları.

Teknik: [Sağ/Sol] omuz MR; yağ baskılı PD/T2 ve T1 sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Supraspinatus tendonunun [anterior] kesiminde [eklem yüzü/bursa yüzü kısmi kat/tam kat] yırtık; retraksiyon [.. mm]. Kasta atrofi veya yağlanma [yok/var]. Subakromiyal-subdeltoid bursada sıvı.

Sonuç: Supraspinatus tendonunda [tam kat/kısmi kat] yırtık; retraksiyon [.. mm].

085 Kalça MR · Femur başı avasküler nekrozu

Ne zaman kullanılır: Kalça ağrısı olan, steroid kullanımı veya risk faktörü bulunan hastalar.

Teknik: Bilateral kalça MR; koronal T1, STIR ve aksiyel sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] femur başında subkondral yerleşimli, T1'de hipointens hatla çevrili harita benzeri alan; T2'de çift çizgi işareti. Eklem yüzeyinde çökme [yok/var]. Eklem efüzyonu [yok/var]. Kontralateral femur başı [olağan/benzer değişiklik].

Sonuç: [Sağ/Sol] femur başı avasküler nekrozu; eklem yüzü çökmesi [izlenmedi/izlendi].

086 Karaciğer MR · Hemanjiyom

Ne zaman kullanılır: USG veya BT'de belirsiz kalan karaciğer lezyonunun karakterizasyonu.

Teknik: Dinamik kontrastlı karaciğer MR; T2, DAG ve arteriyel, portal venöz, gecikmiş fazlar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Karaciğer segment [..]'de [.. mm], T2'de belirgin hiperintens, dinamik serilerde periferik nodüler ve santripetal ilerleyen kontrastlanma gösteren lezyon.

Sonuç: Karaciğer segment [..]'de tipik hemanjiyom ile uyumlu lezyon.

087 MRCP · Koledokolitiazis

Ne zaman kullanılır: Kolestaz bulguları veya safra taşı olan hastada safra yollarının değerlendirilmesi.

Teknik: MRCP; ağır T2 ağırlıklı 2B ve 3B sekanslar.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Koledok distalinde [.. mm] boyutunda, T2'de sinyal boşluğu oluşturan dolum defekti. Koledok [.. mm] çapında, intrahepatik safra yollarında [hafif] dilatasyon. Safra kesesinde [taşlar].

Sonuç: Koledok distalinde taş (koledokolitiazis) ve safra yollarında dilatasyon. Kolanjit klinik şüphesi varsa klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

088 Lomber MR · Spondilodiskit

Ne zaman kullanılır: Ateş, inflamatuvar belirteç yüksekliği ve bel ağrısı ile çekilen kontrastlı MR'lar.

Teknik: Kontrastlı lomber MR; T1, T2, STIR ve kontrast sonrası yağ baskılı T1.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: L[..] diskte T2 hiperintensite ve kontrastlanma; komşu uç plaklarda erozyon ve kemik iliği ödemi. [Paravertebral/epidural] [flegmon/apse] [yok/var].

Sonuç: L[..] spondilodiskit ile uyumlu bulgular; epidural apse [yok/var]. Epidural apse varsa klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

089 Diz MR · Popliteal (Baker) kisti

Ne zaman kullanılır: Diz arkasında şişlik veya ağrısı olan hastalar.

Teknik: [Sağ/Sol] diz MR.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Popliteal fossada, medial gastroknemius ve semimembranozus tendonları arasından uzanan [.. mm] sıvı koleksiyonu. Rüptür lehine çevresel ödem [yok/var].

Sonuç: Popliteal (Baker) kisti; rüptür bulgusu [yok/var].

090 Pelvik MR · Basit adneksiyel kist

Ne zaman kullanılır: USG'de saptanan adneksiyel kistik lezyonun karakterizasyonu.

Teknik: Kontrastlı pelvik MR; T1, yağ baskılı T1, T2, DAG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] overde [.. mm] boyutunda, ince ve düzgün duvarlı, T2'de homojen hiperintens, solid komponent veya kontrastlanan septa içermeyen kistik lezyon.

Sonuç: [Sağ/Sol] overde basit kist ile uyumlu lezyon. Takip gerekliliği hastanın yaşı ve menopoz durumuna göre klinik ekip tarafından belirlenmelidir.

BÖLÜM 4

USG ve Doppler

30 şablon: 5 normal, 25 nöbet ve rutinde sık bulgu (POCUS ve eFAST dahil).

091 Tüm batın USG · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Karın ağrısı veya rutin kontrolde patoloji görmediğiniz batın USG'leri.

Teknik: Tüm batın USG; [açlık durumunda].

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Karaciğer normal boyut ve ekojenitede, fokal lezyon izlenmedi. Safra kesesi doğal duvarlı, lümeni anekoik; taş izlenmedi. İntra ve ekstrahepatik safra yolları dilate değil. Pankreas [görülebilen kesimleri] doğal. Dalak normal boyutta. Her iki böbrek normal boyut ve parankim ekojenitesinde; pelvikalisiyel sistem dilate değil. Mesane [dolu, duvarı doğal]. Batın içinde serbest sıvı izlenmedi.

Sonuç: Tüm batın USG'de patoloji saptanmadı.

092 Üriner sistem USG · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Yan ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek fonksiyon bozukluğunda patoloji görmediğiniz olgular.

Teknik: Üriner sistem USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Her iki böbrek normal boyut, konum ve parankim kalınlığında; kortikomedüller ayrım korunmuş. Pelvikalisiyel sistem dilate değil. Taş veya kitle izlenmedi. Mesane [dolu, duvarı doğal, lümeni anekoik].

Sonuç: Üriner sistem USG'de patoloji saptanmadı.

093 Tiroid USG · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: Tiroid fonksiyon bozukluğu veya ele gelen şişlik sorusunda patoloji görmediğiniz olgular.

Teknik: Tiroid ve boyun USG; yüksek frekanslı lineer prob.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Tiroid bezi normal boyut ve homojen parankim ekojenitesinde. Nodül izlenmedi. Renkli Doppler'de vaskülarite olağan. Boyunda patolojik görünümlü lenf nodu saptanmadı.

Sonuç: Tiroid USG'de patoloji saptanmadı.

094 Alt ekstremite venöz Doppler · Normal

NORMAL

Ne zaman kullanılır: DVT şüphesinde tromboz görmediğiniz venöz Doppler incelemeleri.

Teknik: [Sağ/Sol] alt ekstremite venöz Doppler USG; gri skala kompresyon, renkli ve spektral Doppler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Ana femoral, femoral ve popliteal venler tam kompresibl; lümenlerinde trombüs izlenmedi. Renkli Doppler'de lümen dolumu tam, spektral incelemede solunumla değişkenlik ve augmentasyon yanıtı mevcut. [Baldır venleri değerlendirmeye alınmıştır/alınmamıştır].

Sonuç: [Sağ/Sol] alt ekstremite [derin venlerinde] tromboz saptanmadı.

095 eFAST · Negatif

Ne zaman kullanılır: Travma hastasında yatak başı eFAST'ta serbest sıvı ve pnömotoraks görmediğiniz olgular.

Teknik: Yatak başı eFAST.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Morison poşu, splenorenal alan ve pelvik alanda serbest sıvı izlenmedi. Subksifoid görüntülemede perikardiyal efüzyon yok. Bilateral akciğer kaymasının (lung sliding) varlığı izlenmiştir.

Sonuç: eFAST'ta serbest sıvı, perikardiyal efüzyon veya pnömotoraks lehine bulgu saptanmadı. Negatif eFAST organ yaralanmasını dışlamaz; klinik duruma göre BT önerilir.

096 Batın USG · Kolelitiazis

Ne zaman kullanılır: Safra kesesinde akustik gölge veren ekojen odak gördüğünüz olgular.

Teknik: Batın USG; açlık durumunda.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Safra kesesi lümeninde, en büyüğü [.. mm] boyutunda, posterior akustik gölge veren, pozisyonla hareketli ekojen odaklar. Duvar kalınlığı [olağan/artmış]. Perikolesistik sıvı [yok/var]. Sonografik Murphy bulgusu [negatif/pozitif]. Koledok [.. mm].

Sonuç: Kolelitiazis. Akut kolesistit lehine bulgu [izlenmedi/izlendi].

097 Batın USG · Akut kolesistit

Ne zaman kullanılır: Sağ üst kadran ağrısı, ateş ve sonografik Murphy bulgusu olan olgular.

Teknik: Batın USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış [ve ödemli, çift kontur]; boyun kesiminde [.. mm] taş. Perikolesistik sıvı [var]. Sonografik Murphy bulgusu pozitif.

Sonuç: Akut taşlı kolesistit ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

098 Üriner sistem USG · Hidronefroz

Ne zaman kullanılır: Yan ağrısı, renal kolik veya böbrek fonksiyon bozukluğunda toplayıcı sistem dilatasyonu gördüğünüz olgular.

Teknik: Üriner sistem USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] böbrekte [hafif/orta/belirgin] pelvikalisiyel dilatasyon; proksimal üreter [dilate/izlenmiyor]. Parankim kalınlığı [korunmuş/incelmiş]. Obstrüksiyon nedeni olarak [üreterovezikal bileşkede .. mm taş/net neden izlenmedi]. Mesane [..].

Sonuç: [Sağ/Sol] [hafif/orta/belirgin] hidronefroz; [olası neden]. Neden net değilse kontrastsız BT ile korelasyon önerilir.

099 FAST · Morison poşunda serbest sıvı

Ne zaman kullanılır: Travma hastasında FAST'ta serbest sıvı gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: Yatak başı FAST.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Morison poşunda [ve splenorenal alanda/pelviste] anekoik serbest sıvı. Perikardiyal efüzyon [yok/var].

Sonuç: FAST pozitif: [Morison poşunda] serbest sıvı. Hemodinamik duruma göre acil klinik değerlendirme; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

100 Toraks USG · Plevral efüzyon

Ne zaman kullanılır: Grafide efüzyon şüphesi veya torasentez öncesi miktar ve yer tespiti.

Teknik: Toraks USG; [oturur pozisyonda], interkostal tarama.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol/Bilateral] plevral aralıkta [anekoik/ekojen içerikli/septalı] sıvı; en derin yerinde [.. mm]. Komşu akciğerde kompresif atelektazi. [Plevral nodülarite izlenmedi.]

Sonuç: [Sağ/Sol] [anekoik/komplike görünümlü] plevral efüzyon. [Torasentez için uygun pencere işaretlenmiştir.]

101 Akciğer USG · B çizgileri

Ne zaman kullanılır: Dispne ile gelen hastada yatak başı akciğer USG'de B çizgileri gördüğünüz olgular.

Teknik: Yatak başı akciğer USG; bilateral bölge taraması.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Bilateral [anterior ve lateral] bölgelerde, her alanda çok sayıda B çizgisi. Plevral çizgi [düzgün/düzensiz ve kalınlaşmış]. Plevral efüzyon [yok/var].

Sonuç: Bilateral yaygın B çizgileri; interstisyel sendrom ile uyumlu. Düzgün plevral çizgiyle birlikte kardiyojenik pulmoner ödem lehine olabilir; klinik ve ekokardiyografik korelasyon önerilir.

102 Venöz Doppler · Derin ven trombozu

Ne zaman kullanılır: Bacakta şişlik ve ağrı ile gelen hastada kompresyonla kapanmayan ven gördüğünüz olgular. Bildirim.

Teknik: [Sağ/Sol] alt ekstremite venöz Doppler USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Ana femoral/femoral/popliteal] vende kompresyonla kapanmayan, lümeni [kısmen/tamamen] dolduran ekojen trombüs; renkli Doppler'de [akım yok/parsiyel akım]. Trombüs [proksimal sınırı: ..].

Sonuç: [Sağ/Sol] [femoropopliteal] segmentte akut derin ven trombozu ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

103 Sağ alt kadran USG · Akut apandisit

Ne zaman kullanılır: Çocuk, genç veya gebe hastada sağ alt kadran ağrısında inflame apendiks gördüğünüz olgular.

Teknik: Sağ alt kadran USG; dereceli kompresyon tekniği.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Sağ alt kadranda, kompresyonla kapanmayan, [.. mm] çapında, kör uçlu tübüler yapı (apendiks); duvarında renkli Doppler'de artmış vaskülarite. Çevre yağ dokusunda ekojenite artışı. Apendikolit [var/yok]. Periapendiküler sıvı [yok/var].

Sonuç: Akut apandisit ile uyumlu bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir. / Apendiks görüntülenemedi; bu durum apandisiti dışlamaz.

104 Abdominal aort USG · Anevrizma

Ne zaman kullanılır: Tarama, pulsatil kitle veya karın-sırt ağrısında aortada genişleme gördüğünüz olgular.

Teknik: Abdominal aort USG; transvers ve longitudinal ölçümler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: İnfrarenal abdominal aortada maksimum [.. mm] çapında anevrizmatik genişleme; lümende [mural trombüs]. Periaortik sıvı [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: İnfrarenal abdominal aort anevrizması, maksimum çap [.. mm]. Semptomatik hastada rüptür USG ile dışlanamaz; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir ve BT anjiyografi önerilir.

105 Tiroid USG · Tiroid nodülü

Ne zaman kullanılır: Ele gelen nodül veya rastlantısal tiroid nodülü.

Teknik: Tiroid USG; lineer prob, renkli Doppler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Tiroid [sağ/sol] lob [üst/orta/alt] kesiminde [.. x .. x .. mm] boyutunda, [solid/kistik/miks], [hipoekoik/izoekoik/hiperekoik], [düzgün/düzensiz] sınırlı nodül. Mikrokalsifikasyon [yok/var]. [Uzun eksen dikey yönelim yok/var]. Boyunda patolojik lenf nodu [yok/var].

Sonuç: Tiroid [sağ lob] da [.. mm] nodül; kurumunuzun kullandığı risk sınıflamasına göre [kategori]. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve takip gerekliliği bu sınıflamaya göre belirlenmelidir.

106 Batın USG · Hepatosteatoz

Ne zaman kullanılır: Karaciğer parankim ekojenitesinde diffüz artış gördüğünüz olgular.

Teknik: Batın USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Karaciğer [normal boyutta/büyümüş]; parankim ekojenitesi böbrek korteksine göre diffüz artmış; portal ven duvarları ve diyafram [seçilebiliyor/seçilemiyor]. Fokal lezyon izlenmedi.

Sonuç: [Hafif/Orta/Belirgin] hepatosteatoz ile uyumlu görünüm.

107 Pelvik USG · Ektopik gebelik şüphesi

Ne zaman kullanılır: Gebelik testi pozitif hastada uterin gebelik görülmediği olgular. Bildirim.

Teknik: Transabdominal [ve transvajinal] pelvik USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi. [Sağ/Sol] adneksiyel alanda overden ayrı [.. mm] heterojen kitle [/içinde yolk kesesi veya embriyo]. Douglas boşluğunda [ekojen içerikli] serbest sıvı [var/yok].

Sonuç: Uterin gebelik izlenmedi; [sağ/sol] adneksiyel kitle ve [serbest sıvı] ile birlikte ektopik gebelik lehine bulgular. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

108 Ekokardiyografik pencere / POCUS · Perikardiyal efüzyon

Ne zaman kullanılır: Dispne, hipotansiyon veya travmada subksifoid görüntülemede perikardiyal sıvı gördüğünüz olgular.

Teknik: Yatak başı subksifoid [ve parasternal] görüntüleme.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Perikardiyal aralıkta [çepeçevre/lokalize] anekoik sıvı; en geniş yerinde [.. mm]. Sağ atriyum/sağ ventrikül diyastolik kollapsı [izlenmedi/izlendi].

Sonuç: [Az/Orta/Fazla] perikardiyal efüzyon. Tamponad lehine bulgu [yok/var; acil bulgu olarak bildirildi]. Ayrıntılı değerlendirme için ekokardiyografi önerilir.

109 Üriner sistem USG · Basit böbrek kisti

Ne zaman kullanılır: Rastlantısal, anekoik böbrek lezyonları.

Teknik: Üriner sistem USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] böbrek [üst/orta/alt] polde [.. mm] boyutunda, ince duvarlı, anekoik, posterior akustik güçlenme gösteren, septa veya solid komponent içermeyen kist.

Sonuç: [Sağ/Sol] böbrekte basit kortikal kist ile uyumlu lezyon.

110 Batın USG · Karaciğer apsesi

Ne zaman kullanılır: Ateş ve sağ üst kadran ağrısında karaciğerde komplike kistik lezyon gördüğünüz olgular.

Teknik: Batın USG; renkli Doppler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Karaciğer segment [..]'de [.. mm] boyutunda, düzensiz duvarlı, internal ekoları ve [debrisi] olan hipoekoik/kompleks kistik lezyon; çevresinde [hiperemi].

Sonuç: Karaciğer segment [..]'de apse ile uyumlu olabilecek lezyon. Klinik ve laboratuvar korelasyonu; gerekirse kontrastlı BT önerilir. Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

111 Skrotal Doppler USG · Testis torsiyonu şüphesi

Ne zaman kullanılır: Ani başlayan skrotal ağrıda etkilenen testiste akım azalması gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: Skrotal gri skala ve renkli/spektral Doppler USG; kontralateral testisle karşılaştırmalı.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] testis [büyümüş, heterojen]; renkli Doppler'de intratestiküler akım [izlenmedi/karşı tarafa göre belirgin azalmış]. Spermatik kordda [girdap görünümü]. Kontralateral testis doğal.

Sonuç: [Sağ/Sol] testis torsiyonu ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir. Akım varlığı torsiyonu tamamen dışlamaz.

112 Batın USG · Asit

Ne zaman kullanılır: Karın şişliği veya parasentez öncesi sıvı değerlendirmesi.

Teknik: Batın USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: Batın içinde perihepatik, perisplenik ve pelvik alanlarda [az/orta/fazla] miktarda [anekoik/ekojen içerikli/septalı] serbest sıvı. Karaciğer konturu [düzgün/nodüler].

Sonuç: [Az/Orta/Fazla] miktarda asit. [Parasentez için uygun pencere işaretlenmiştir.]

113 Meme USG · Basit kist

Ne zaman kullanılır: Ele gelen kitle veya mamografide saptanan lezyonun USG ile değerlendirilmesi.

Teknik: Bilateral meme USG; lineer prob.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] meme saat [..] hizasında, meme başından [.. cm] uzaklıkta, [.. mm] boyutunda, oval, düzgün sınırlı, anekoik, posterior akustik güçlenme gösteren lezyon.

Sonuç: [Sağ/Sol] memede basit kist ile uyumlu lezyon; kurumunuzun kullandığı sınıflamaya göre [kategori].

114 Karotis Doppler USG · Aterosklerotik plak

Ne zaman kullanılır: İnme, geçici iskemik atak veya vasküler risk taramasında karotis değerlendirmesi.

Teknik: Bilateral karotis ve vertebral arter Doppler USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] [ana karotis/bulbus/internal karotis] arterde [kalsifik/hipoekoik/heterojen] aterosklerotik plak. Plak düzeyinde tepe sistolik akım hızı [.. cm/s]. Vertebral arterlerde akım [antegrad].
Sonuç: [Sağ/Sol] [internal karotis] arterde aterosklerotik plak; darlık derecesi kurumunuzun kullandığı Doppler kriterlerine göre [derece]. Belirgin darlıkta BT veya MR anjiyografi ile korelasyon önerilir.

115 Batın USG · Koledok dilatasyonu

Ne zaman kullanılır: Kolestaz enzim yüksekliği veya sarılıkta safra yollarının genişlediği olgular.

Teknik: Batın USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: Koledok [.. mm] çapında dilate; intrahepatik safra yolları [dilate/dilate değil]. Distal koledokta [.. mm taş/obstrüksiyon nedeni seçilemedi; distal kesim barsak gazı nedeniyle görüntülenemedi]. Safra kesesinde [taş var/yok].
Sonuç: Koledok dilatasyonu; [olası neden]. Neden belirlenemediyse MRCP önerilir.

116 Üriner sistem USG · Böbrek taşı

Ne zaman kullanılır: Yan ağrısı veya hematüride böbrekte akustik gölge veren odak gördüğünüz olgular.

Teknik: Üriner sistem USG.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] böbrek [alt/orta/üst] pol kaliksinde [.. mm] boyutunda, akustik gölge veren ekojen odak (renkli Doppler'de parıldama artefaktı [var]). Pelvikalisiyel sistem [dilate değil/dilate].
Sonuç: [Sağ/Sol] böbrekte [.. mm] taş; [hidronefroz yok/hidronefroz eşlik ediyor].

117 Akciğer POCUS · Pnömotoraks bulguları

Ne zaman kullanılır: Travma veya girişim sonrası yatak başı akciğer USG'de akciğer kaymasının izlenmediği olgular. Acil bildirim.

Teknik: Yatak başı akciğer USG; anterior göğüs duvarı, M-mod.
Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.
Bulgular: [Sağ/Sol] anterior göğüs duvarında akciğer kayması (lung sliding) izlenmedi; B çizgisi yok. M-modda [barkod/stratosfer işareti]. Akciğer noktası (lung point) [izlendi/izlenmedi].
Sonuç: [Sağ/Sol] pnömotoraks lehine bulgular ([akciğer noktası izlendi]). Klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

118 Batın USG (çocuk) · İnvajinasyon

Ne zaman kullanılır: Aralıklı karın ağrısı ve kusma ile gelen küçük çocuklarda hedef görünümü gördüğünüz olgular. Acil bildirim.

Teknik: Batın USG; lineer ve konveks prob.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ üst kadran/Sağ abdomen] de, transvers kesitte hedef (target) görünümü, longitudinal kesitte psödoböbrek görünümü veren [.. mm] çapında barsak segmenti. İçinde [lenf nodu/öncü nokta] [yok/var]. Renkli Doppler'de duvar akımı [korunmuş/azalmış]. Çevrede serbest sıvı [yok/var].

Sonuç: [İleokolik] invajinasyon ile uyumlu bulgular. Acil bulgu; klinik ekibe [saat]'te bildirilmiştir.

119 Skrotal Doppler USG · Epididimoorşit

Ne zaman kullanılır: Skrotal ağrı ve şişlikte epididimde hiperemi gördüğünüz olgular.

Teknik: Skrotal gri skala ve renkli Doppler USG.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Sağ/Sol] epididim [baş/gövde] kesimi büyümüş ve heterojen; renkli Doppler'de belirgin artmış vaskülarite. Testiste [hiperemi var/yok]. Reaktif hidrosel [var/yok]. Kontralateral testis ve epididim doğal.

Sonuç: [Sağ/Sol] [epididimit/epididimoorşit] ile uyumlu bulgular. Testiküler akım korunmuştur.

120 Yumuşak doku USG · Apse

Ne zaman kullanılır: Ciltaltında şişlik, kızarıklık ve ağrı olan olgularda koleksiyon araştırması.

Teknik: Yüzeyel yumuşak doku USG; lineer prob, renkli Doppler.

Karşılaştırma: [tarih] tarihli önceki tetkik ile karşılaştırılmıştır. / Karşılaştırılacak önceki tetkik bulunmamaktadır.

Bulgular: [Bölge] de ciltaltı yağ dokusunda [.. mm] boyutunda, düzensiz sınırlı, internal ekolu, kompresyonla hareket eden içeriği olan hipoekoik koleksiyon; çevresinde artmış vaskülarite ve ödem (kaldırım taşı görünümü).

Sonuç: [Bölge] de yumuşak doku apsesi ile uyumlu koleksiyon ve çevresel selülit bulguları.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi Bonus 1 · 200 Sonuç Cümlesi Bankası'nı açın. Şablonun en zor kısmı Sonuç alanıdır; bankadaki normal, insidental ve acil bulgu cümleleriyle her raporu tek ve net bir cümleyle kapatın.

İmzalamadan önce **Hızlı bonus · Tek Sayfa Rapor Kontrol Listesi**'ni yanınızda tutun.